

KPOK

Дитина віком 12 років хворіє на поліомієліт. Починають виникати парези та паралічі. Які методи реабілітації будуть використовуватися у цьому періоді?

A. Статичні дихальні вправи та лікування положенням

B. –

C. ЛФК та фізіотерапевтичні процедури

D. Гідрокінезіотерапія та масаж

E. Масаж та терапевтичні вправи



Дитина віком 12 років хворіє на поліомієліт. Починають виникати парези та паралічі. Які методи реабілітації будуть використовуватися у цьому періоді?

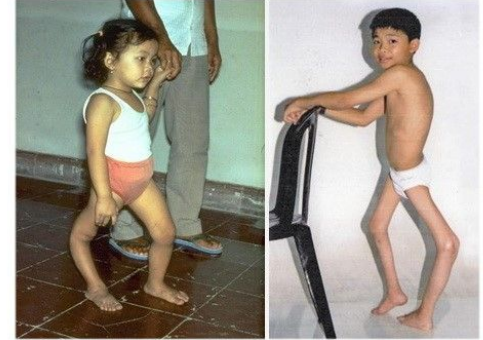
A. Статичні дихальні вправи та лікування положенням

B. –

C. ЛФК та фізіотерапевтичні процедури

D. Гідрокінезіотерапія та масаж

E. Масаж та терапевтичні вправи



У гострому періоді поліомієліту, коли парези тільки формуються, єдиною правильною тактикою є щадна реабілітація, спрямована на профілактику ускладнень, а не на активне відновлення. Саме тому використовуються статичні дихальні вправи та лікування положенням.

Після родової травми у новонародженої дитини спостерігається: обмеження руху верхньої кінцівки, гіпорексія, м'язова атрофія. До якого виду рухових порушень належать ці зміни нервової системи?

- A. Бульбарні розлади
- B. Порушення нижнього мотонейрона
- C. Міастенія
- D. Пірамідальні порушення
- E. Порушення верхнього мотонейрона



Після родової травми у новонародженої дитини спостерігається: обмеження руху верхньої кінцівки, гіпорексія, м'язова атрофія. До якого виду рухових порушень належать ці зміни нервової системи?

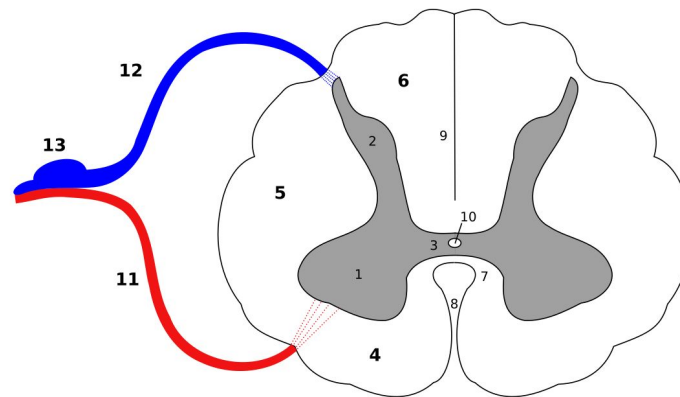
A. Бульбарні розлади

B. Порушення нижнього мотонейрона

C. Міастенія

D. Пірамідальні порушення

E. Порушення верхнього мотонейрона



Gray matter

- 1. Anterior horn
- 2. Posterior horn
- 3. Gray commissure

White matter

- 4. Anterior funiculus
- 5. Lateral funiculus
- 6. Posterior funiculus
- 7. Anterior commissure
- 8. Anterior median fissure
- 9. Posterior median sulcus

- 10. Central canal
- 11. Anterior root
- 12. Posterior root
- 13. Dorsal root ganglion

У підлітка віком 15 років під час візуального обстеження було з'ясовано, що грудна клітка заглиблена в нижній частині грудини, особливо в ділянці мечоподібного відростка. На яку форму грудної клітки вказують отримані результати обстеження?

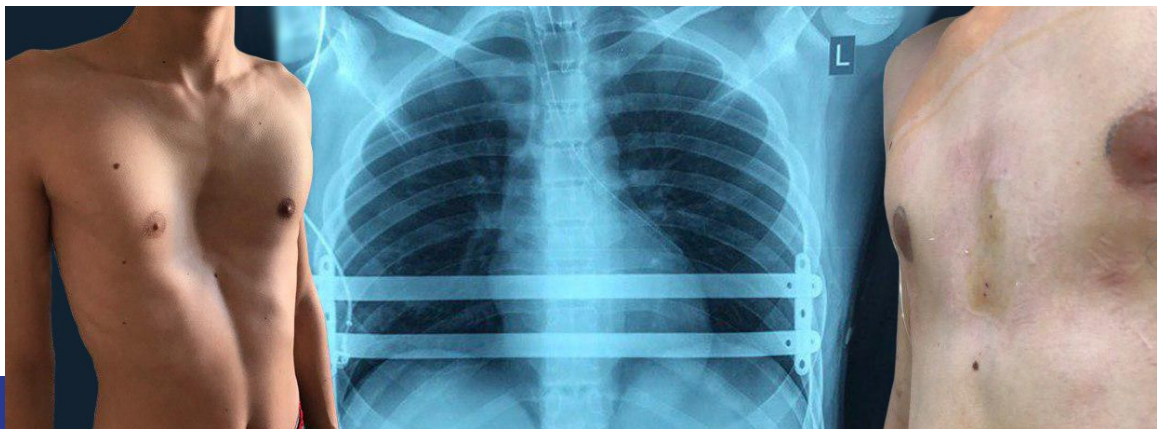
- A. Емфізематорну
- B. Рахітичну
- C. Лійкоподібну
- D. Астенічну
- E. Воронкоподібну



У підлітка віком 15 років під час візуального обстеження було з'ясовано, що грудна клітка заглиблена в нижній частині грудини, особливо в ділянці мечоподібного відростка. На яку форму грудної клітки вказують отримані результати обстеження?

- A. Емфізематорну
- B. Рахітичну
- C. Лійкоподібну**
- D. Астенічну
- E. Воронкоподібну

Заглиблення грудної клітки в нижній частині грудини, особливо в ділянці мечоподібного відростка, є характерною ознакою лійкоподібної (або воронкоподібної) деформації грудної клітки.



Термінологічна різниця між «лійкоподібною» та «воронкоподібною» грудною клітиною:

У сучасній медичній літературі ці терміни часто використовуються як синоніми, однак деякі джерела уточнюють, що є певні відмінності у формах та локалізації заглиблення:

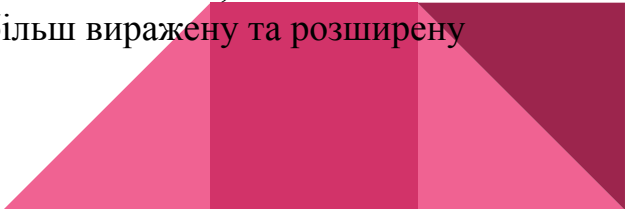
1. Лійкоподібна грудна клітина характеризується заглибленням, яке чітко локалізується в нижній частині груднини і зазвичай не зачіпає середню ділянку.
2. Воронкоподібна грудна клітина має більш широке заглиблення, що охоплює середню та нижню частини груднини, створюючи вигляд «воронки».

Фізіологічні особливості форми деформації:

У завданні наголошено, що заглиблення є лише в нижній ділянці мечоподібного відростка. Це відповідає опису лійкоподібної форми грудної клітини, де основна деформація зосереджена в нижньому сегменті.

Клінічна практика та специфіка опису:

Для уточнення діагнозу та визначення форми грудної клітини лікарі та фізичні терапевти орієнтуються на чіткі анатомічні особливості. Термін «лійкоподібна» вказує на обмежене заглиблення, яке не поширюється на всю груднину, тоді як «воронкоподібна» зазвичай описує більш виражену та розширену деформацію.



У підлітка віком 14 років під час візуального обстеження грудної клітки груднина виступає вперед у вигляді гребеня (кіля). Пальпаторно в місцях переходу реберних хрящів у кістку фіксуються чоткоподібні потовщення. На яку форму грудної клітки вказують результати обстеження?

- A. Лійкоподібна
- B. Рахітична
- C. Емфізематозна
- D. Гіперстенічна
- E. Астенічна



У підлітка віком 14 років під час візуального обстеження грудної клітки груднина виступає вперед у вигляді гребеня (кіля). Пальпаторно в місцях переходу реберних хрящів у кістку фіксуються чоткоподібні потовщення. На яку форму грудної клітки вказують результати обстеження?

- A. Лійкоподібна
- B. Рахітична**
- C. Емфізематозна
- D. Гіперстенічна
- E. Астенічна

**Кілеподібна деформація
грудної клітки**



Вкажіть форму ДЦП для якої характерно: несвідомі, неконтрольовані, повторювані, іноді стереотипні рухи уражених частин тіла, а також патологічний зразок положення тіла та/або рухів.

A. Спастична диплегія

B. Атаксія

C. Дискінетична

D. Спастичний геміпарез

E. Спастичний тетрапарез



Вкажіть форму ДЦП для якої характерно: несвідомі, неконтрольовані, повторювані, іноді стереотипні рухи уражених частин тіла, а також патологічний зразок положення тіла та/або рухів.

- A. Спастична диплегія
- B. Атаксія
- C. Дискінетична
- D. Спастичний геміпарез
- E. Спастичний тетрапарез



- Спастична *диплегія*: у пацієнта спостерігається спастичність та рухові труднощі, які більше впливають на ноги, ніж на руки.
 - Спастична *геміплегія*: у пацієнта спостерігається спастичність та рухові труднощі, що вражають одну сторону тіла; руки часто задіяні більше, ніж ноги.
 - Спастична *квадриплегія*: у пацієнта спостерігається спастичність та рухові труднощі, що вражають усі 4 кінцівки; часто спостерігається більше ураження верхніх кінцівок порівняно з ногами.
 - *Дискінетичний/гіперкінетичний (хореоатетоїдний)*: у пацієнта спостерігаються надмірні, мимовільні рухи, що характеризуються поєднанням швидких, танцювальних скорочень м'язів та повільних корчів.
 - *Дистонічний*: у пацієнта спостерігаються мимовільні, тривалі скорочення м'язів, що викликають скручування та повторювані рухи.
 - *Атаксичний*: у пацієнта спостерігається нестійкість та порушення координації рухів, а також гіпотонія.
- 

Дванадцятирічній дівчинці встановлено діагноз: ДЦП. По дому та в школі зазвичай ходить самостійно, але інколи, для більшої безпеки, використовує тростинку. Сходишками може підійматися тільки тримаючись за перила. Стрибати та бігати не вміє. Визначте рівень рухових порушень за GMFCS.

A. I

B. V

C. IV

D. III

E. II



Дванадцятирічній дівчинці встановлено діагноз: ДЦП. По дому та в школі зазвичай ходить самостійно, але інколи, для більшої безпеки, використовує тростинку. Сходишками може підійматися тільки тримаючись за перила. Стрибати та бігати не вміє. Визначте рівень рухових порушень за GMFCS.

A. I

B. V

C. IV

D. III

E. II

- Рівень I: Ходить самостійно без обмежень.
- Рівень II: Ходить самостійно, але з обмеженнями (на нерівній поверхні, сходах).
- Рівень III: Ходить із допомогою допоміжних засобів (милиці, ходунки).
- Рівень IV: Самостійне пересування обмежене, переважно використовує крісло колісне (з приводом від рук або з допомогою).
- Рівень V: Пересування в кріслі колісному з повною допомогою, важкість утримання голови та тулуба.



Під час обстеження чотиримісячної дитини щодо підвищеного тону м'язів фізичним терапевтом використано тест для оцінки ризику розвитку церебрального паралічу, що включає неврологічне обстеження, оцінку розвитку моторних функцій та поведінку. Який тест використав фізичний терапевт у цьому разі?

- A. GMFCS
- B. PEDI
- C. AIMS
- D. Ашворта
- E. HINE



Під час обстеження чотиримісячної дитини щодо підвищеного тону м'язів фізичним терапевтом використано тест для оцінки ризику розвитку церебрального паралічу, що включає неврологічне обстеження, оцінку розвитку моторних функцій та поведінку. Який тест використав фізичний терапевт у цьому разі?

A. GMFCS

B. PEDI

C. AIMS

D. Ашворта

E. HINE

Діапазон:   Пр Лів Пр Лів		 Пр Лів	  Пр Лів Пр Лів
Опір, який можна подолати  Пр Лів	Опір, який важко подолати Пр Лів	Відсутність опору  Пр Лів	Опір, який неможливо подолати  Пр Лів
Повна пронація та супінація, Відсутність опору		Опір повній пронації/супінації, який можна подолати	Повні пронація та супінація неможливі, виражений опір
Діапазон: 150-80°   Пр Лів Пр Лів	150-160°  Пр Лів	>170°  Пр Лів	<80°  Пр Лів
Діапазон: 150°-100°   Пр Лів Пр Лів	150-160°  Пр Лів	-90° або > 170°   Пр Лів Пр Лів	<80°  Пр Лів
Діапазон: 30°-85°   Пр Лів Пр Лів	20-30°  Пр Лів	<20° or 90°   Пр Лів Пр Лів	> 90°  Пр Лів
 			
 			

Новонародженій дитині діагностовано правобічну вроджену м'язову кривошию, На що треба спрямувати заходи фізичної терапії в цьому разі?

- A. Стимуляцію груднинно-ключично-соскоподібного м'яза з лівого боку та стимуляцію трапецієподібного м'яза з правого боку
- B. Розслаблення груднинно-ключично-соскоподібного м'яза з правого боку, стимуляцію трапецієподібного м'яза з лівого боку
- C. Розслаблення груднинно-ключично-соскоподібного та трапецієподібного м'язів з правого боку, стимуляцію цих м'язів з лівого боку
- D. Розслаблення трапецієподібних м'язів з обох боків та стимуляцію груднинно-ключично-соскоподібного м'яза з правого боку
- E. Стимуляцію груднинно-ключично-соскоподібних м'язів із правого та лівого боків, стимуляцію трапецієподібних м'язів з обох боків



Новонародженій дитині діагностовано правобічну вроджену м'язову кривошию, На що треба спрямувати заходи фізичної терапії в цьому разі?

А. Стимуляцію груднинно-ключично-соскоподібного м'яза з лівого боку та стимуляцію трапецієподібного м'яза з правого боку

В. Розслаблення груднинно-ключично-соскоподібного м'яза з правого боку, стимуляцію трапецієподібного м'яза з лівого боку

С. Розслаблення груднинно-ключично-соскоподібного та трапецієподібного м'язів з правого боку, стимуляцію цих м'язів з лівого боку

Д. Розслаблення трапецієподібних м'язів з обох боків та стимуляцію груднинно-ключично-соскоподібного м'яза з правого боку

Е. Стимуляцію груднинно-ключично-соскоподібних м'язів із правого та лівого боків, стимуляцію трапецієподібних м'язів з обох боків 130. Під час планового огляду тримісячного хлопчика неврологом виявлено значно підвищений тонус м'язу



Під час планового огляду тримісячного хлопчика неврологом виявлено значно підвищений тонус м'язів-розгиначів і привідних м'язів обох ніг, а також надмірний тонус черевних м'язів. Про яку форму ДЦП можуть свідчити такі клінічні ознаки?

- A. Спастичну диплегію
 - B. Спастичну геміплегію
 - C. Атонічно-астатичну форму Ферстера
 - D. Гіперкінетичну
 - E. Дискінетичну
- 

Під час планового огляду тримісячного хлопчика неврологом виявлено значно підвищений тонус м'язів-розгиначів і привідних м'язів обох ніг, а також надмірний тонус черевних м'язів. Про яку форму ДЦП можуть свідчити такі клінічні ознаки?

A. Спастичну диплегію

B. Спастичну геміплегію

C. Атонічно-астатичну форму Ферстера

D. Гіперкінетичну

E. Дискінетичну



Які клінічні прояви характерні для повздовжньої плоскостопості?

a.Пронація стопи

b.Інверсія стопи

c.Hallux valgus

d.Аддукція переднього відділу стопи

e.Супінація стопи



Які клінічні прояви характерні для повздовжньої плоскостопості?

а.Пронація стопи

б.Інверсія стопи

с.Hallux valgus

д.Аддукція переднього відділу стопи

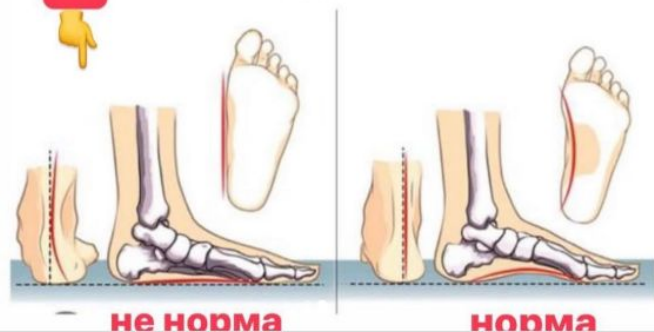
е.Супінація стопи

ПЛОСКОСТОПСТІ :

1 -поперечна



2 -повздовжня



Повздожня плоскостопість — це деформація стопи, при якій знижується або повністю зникає повздожній склепіння стопи (підйом). Це призводить до характерних клінічних проявів, головним з яких є пронація стопи.

Що таке пронація стопи?

Це комплексний рух, який включає:

1. Вальгусне положення п'ятки (п'ята відхиляється назовні).
2. Абдукцію переднього відділу стопи (передній відділ стопи відводиться назовні).
3. Опущення склепіння.

Саме ця триєдина комбінація (п'ятка валгус + передній відділ абдукція + опущене склепіння) і є типовим клінічним проявом повздожньої плоскостопості. Стопа "завалюється" всередину.

Чому інші варіанти не підходять:

- b. Інверсія стопи та e. Супінація стопи: Це протилежні до пронації явища. При інверсії/супінації стопа "завалюється" на зовнішній край, а склепіння може підвищуватися (порожня стопа). Це не характерно для плоскостопості.
- c. Hallux valgus: Це деформація першого пальця стопи (його відхилення назовні), яка часто супутнює запущеній плоскостопості, але не є основним і прямим її клінічним проявом.
- d. Аддукція переднього відділу стопи: Це приведення переднього відділу стопи (поворот носка всередину). Цей симптом характерний для варусних деформацій (наприклад, косолапості), а не для плоскостопості. При плоскостопості спостерігається протилежне — абдукція (відведення).

При якому типі порушення постави спостерігається гіперлордоз поперекового відділу?

- а.Плоска спина
- б.Сутула спина
- с.Кіфосколіоз
- д.Кругло-увігнута спина
- е.Сколіотична постава



При якому типі порушення постави спостерігається гіперлордоз поперекового відділу?

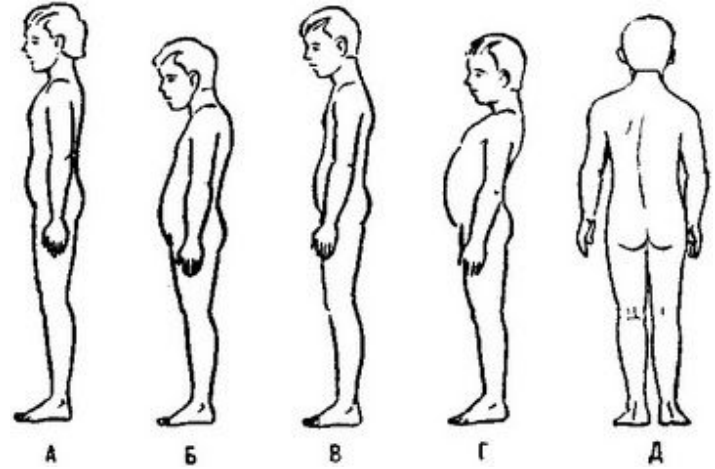
а.Плоска спина

б.Сутула спина

с.Кіфосколіоз

д.Кругло-увігнута спина

е.Сколіотична постава



А - правильна постава. Б - кругла спина, плоска спина, Р - кругло-увігнута спина,

Д - порушення постави у фронтальній площині

п'ятирічного хлопчика, розумово збереженого, ДЦП проявляється нерегулярними спонтанними швидкими змінами --- скорочення-розслаблення м'язів рук і ніг, мімічних м'язів обличчя, на тлі загального зниженого м'язового тону. Коли дитина хвилюється, рухи рук і голови посилюються. У хлопчика також є порушення артикуляції і темпу мовлення. Про яку форму ДЦП свідчать такі клінічні показники?

а.Змішану форму

б.Спастичну геміплегію

с.Атонічно-астатичну форму Ферстера

д.Спастичну диплегію

е.Гіперкінетичну форму



п'ятирічного хлопчика, розумово збереженого, ДЦП проявляється нерегулярними спонтанними швидкими змінами --- скорочення-розслаблення м'язів рук і ніг, мімічних м'язів обличчя, на тлі загального зниженого м'язового тону. Коли дитина хвилюється, рухи рук і голови посилюються. У хлопчика також є порушення артикуляції і темпу мовлення. Про яку форму ДЦП свідчать такі клінічні показники?

а.Змішану форму

б.Спастичну геміплегію

с.Атонічно-астатичну форму Ферстера

д.Спастичну диплегію

е.Гіперкінетичну форму (дискінетична інша назва)



Тримісячній дівчинці встановлено діагноз: вада розвитку ЦНС, мієломенінгоцеле попереково-крижового відділу хребта, spina bifida L4-S1. Який імовірний прогноз щодо набуття рухових навичок у цьому разі?

- a. Із затримкою навчиться сидіти з опорою на руки, зможе навчитися повзати тільки по-пластунськи, до 5 років може навчитися ходити в ортезах KAFO або HKAFO з використанням ходунків або милиць
- b. Сидіти незалежно, перевертатись і повзати навчиться вчасно, до 2 років навчиться ходити, потребуватиме тренувань на витривалість та зміцнення м'язів, використання ортопедичних устілок
- c. Із затримкою навчиться сидіти за умови підтримки тулуба, можливе опанування перекачування, основний спосіб пересування - крісло колісне
- d. Сидіти незалежно, перевертатися, повзати і ходити навчиться вчасно
- e. Сидіти незалежно та перевертатися навчиться вчасно, до 2-3 років навчиться повзати, до 4 років може навчитися ходити в ортезах AFO або KAFO



Тримісячній дівчинці встановлено діагноз: вада розвитку ЦНС, мієломенінгоцеле попереково-крижового відділу хребта, spina bifida **L4-S1**. Який імовірний прогноз щодо набуття рухових навичок у цьому разі?

- a. Із затримкою навчитися сидіти з опорою на руки, зможе навчитися повзати тільки по-пластунськи, до 5 років може навчитися ходити в ортезах KAFO або HKAFO з використанням ходунків або милиць
- b. Сидіти незалежно, перевертатись і повзати навчитися вчасно, до 2 років навчитися ходити, потребуватиме тренувань на витривалість та зміцнення м'язів, використання ортопедичних устілок
- c. Із затримкою навчитися сидіти за умови підтримки тулуба, можливе опанування перекачування, основний спосіб пересування - крісло колісне
- d. Сидіти незалежно, перевертатися, повзати і ходити навчитися вчасно
- e. **Сидіти незалежно та перевертатися навчитися вчасно, до 2-3 років навчитися повзати, до 4 років може навчитися ходити в ортезах AFO або KAFO**



Двомісячній дитині встановлено діагноз: вада розвитку ЦНС, мієломенінгоцеле грудного відділу хребта, spina bifida Th8-Th11. Який імовірний прогноз щодо набуття рухових навичок у цьому разі?

a. Сидіти незалежно та перевертатися навчиться вчасно, до 2-3 років навчиться повзати, до 4 років може навчитися ходити в ортезах AFO або KAFO

b. Із затримкою навчиться сидіти за умови підтримки тулуба, можливе опанування перекачування, основний спосіб пересування - крісло колісне

c. Сидіти незалежно, перевертатись і повзати навчиться вчасно, до 2 років навчиться ходити, потребуватиме тренувань на витривалість і зміцнення м'язів, використання ортопедичних устілок

d. Сидіти незалежно, перевертатися, повзати та ходити навчиться вчасно

e. Із затримкою навчиться сидіти з опорою на руки, зможе навчитися повзати тільки по-пластунськи, до 5 років може навчитися ходити в ортезах KAFO або HKAFO з використанням ходунків або милиць

Двомісячній дитині встановлено діагноз: вада розвитку ЦНС, мієломенінгоцеле грудного відділу хребта, spina bifida **Th8-Th11**. Який імовірний прогноз щодо набуття рухових навичок у цьому разі?

a. Сидіти незалежно та перевертатися навчиться вчасно, до 2-3 років навчиться повзати, до 4 років може навчитися ходити в ортезах AFO або KAFO

b. Із затримкою навчиться сидіти за умови підтримки тулуба, можливе опанування перекачування, основний спосіб пересування - крісло колісне

c. Сидіти незалежно, перевертатись і повзати навчиться вчасно, до 2 років навчиться ходити, потребуватиме тренувань на витривалість і зміцнення м'язів, використання ортопедичних устілок

d. Сидіти незалежно, перевертатися, повзати та ходити навчиться вчасно

e. Із затримкою навчиться сидіти з опорою на руки, зможе навчитися повзати тільки по-пластунськи, до 5 років може навчитися ходити в ортезах KAFO або HKAFO з використанням ходунків або милиць

Переважне використання яких вправ/рухів передбачає методика проведення занять фізичною терапією, якщо вік пацієнта становить 4 роки?

- a. Імітаційні рухи
- b. Ідеомоторні вправи
- c. Рефлекторні вправи
- d. Прикладні фізичні вправи
- e. Спортивні вправи



Переважне використання яких вправ/рухів передбачає методика проведення занять фізичною терапією, якщо вік пацієнта становить 4 роки?

a. Імітаційні рухи

b. Ідеомоторні вправи

c. Рефлекторні вправи

d. Прикладні фізичні вправи

e. Спортивні вправи



Семирічній дитині встановлено діагноз: дитячий церебральний параліч, спастичний парепарез нижніх кінцівок. Об'єктивно спостерігається: самостійно ходить у приміщенні та на вулиці, піднімається сходами, тримаючись за поручні, має труднощі під час ходьби по нерівній поверхні та обмеження бігу й стрибків. Якому рівню відповідно до системи класифікації великих моторних функцій GMFCS відповідають рухові можливості цієї дитини?

a.I

b.III

c.II

d.IV

e.V



Семирічній дитині встановлено діагноз: дитячий церебральний параліч, спастичний паропарез нижніх кінцівок. Об'єктивно спостерігається: самостійно ходить у приміщенні та на вулиці, піднімається сходами, тримаючись за поручні, має труднощі під час ходьби по нерівній поверхні та обмеження бігу й стрибків. Якому рівню відповідно до системи класифікації великих моторних функцій GMFCS відповідають рухові можливості цієї дитини?

- a.I
- b.III
- c.II
- d.IV
- e.V



Під час стоматоскопічного та антропометричного огляду чоловіка було виявлено перевагу поздовжніх розмірів тіла над поперечними: довгі та тонкі кінцівки, довга та тонка шия, вузькі плечі, вузька та плоска грудна клітина, гострий епігастральний кут, крилоподібні лопатки, сутулувата постава, тонка, суха і бліда шкіра, слабо розвинуті м'язи та незначні жировідкладення. До якого типу тілобудови відноситься пацієнт (за Черноруцьким)?

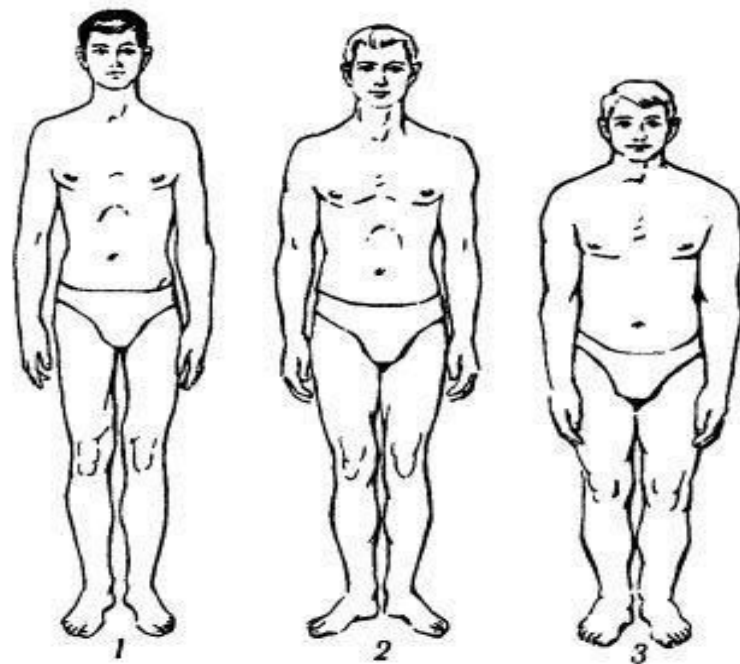
- a. Нормостенічного
- b. Гіпостенічного
- c. Гіперстенічного
- d. Астенічного
- e. Атонічного



Під час стоматоскопічного та антропометричного огляду чоловіка було виявлено перевагу поздовжніх розмірів тіла над поперечними: довгі та тонкі кінцівки, довга та тонка шия, вузькі плечі, вузька та плоска грудна клітина, гострий епігастральний кут, крилоподібні лопатки, сутулувата постава, тонка, суха і бліда шкіра, слабо розвинуті м'язи та незначні жировідкладення. До якого типу тілобудови відноситься пацієнт (за Черноруцьким)?

- a. Нормостенічного
- b. Гіпостенічного
- c. Гіперстенічного
- d. Астенічного**
- e. Атонічного

Описані антропометричні характеристики (перевага поздовжніх розмірів, довгі та тонкі кінцівки, вузька грудна клітка, гострий епігастральний кут, слабо розвинені м'язи, тонка шкіра) відповідають астенічному типу тілобудови за класифікацією Черноруцького.



Мал. 8. Типи конституції людини:
1 — астенічний (доліхоморфний); 2 — нормостенічний (мезоморфний); 3 — гіперстенічний (брахіморфний).

Під час обстеження підлітка реабілітолог виявив асиметрію хребта: лінія плечей і нижній кут лопатки знижені в лівий бік, лопатка наближається до хребта. Яка патологія у пацієнта?

a. Кіфоз

b. Сколіотична постава

c. Кругла спина

d. Плоска спина

e. Лордоз



Під час обстеження підлітка реабілітолог виявив асиметрію хребта: лінія плечей і нижній кут лопатки знижені в лівий бік, лопатка наближається до хребта. Яка патологія у пацієнта?

a. Кіфоз

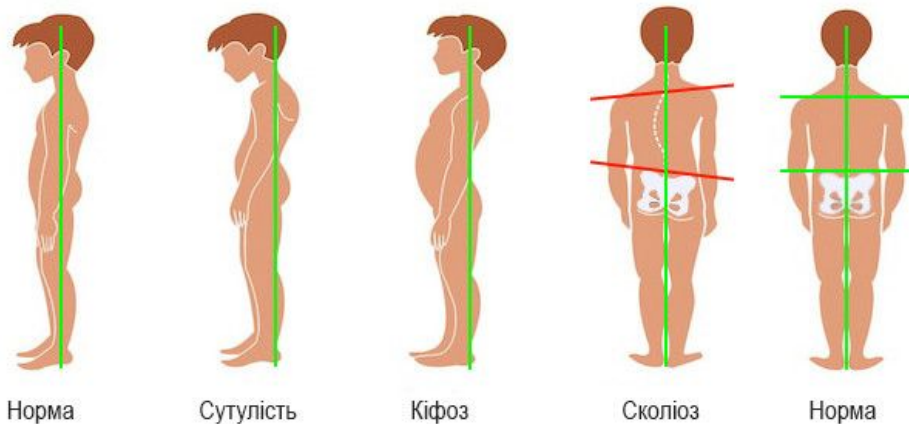
b. **Сколіотична постава**

c. Кругла спина

d. Плоска спина

e. Лордоз

Описані ознаки (асиметрія плечей, лопаток, наближення лопатки до хребта) свідчать про сколіотичну поставу - викривлення хребта у фронтальній площині.



Яку шкалу використовують в ерготерапії для стандартизованої оцінки рівня розвитку великих моторних функцій у дітей з церебральним паралічем?

a.MACS

b.FIM

c.FMS

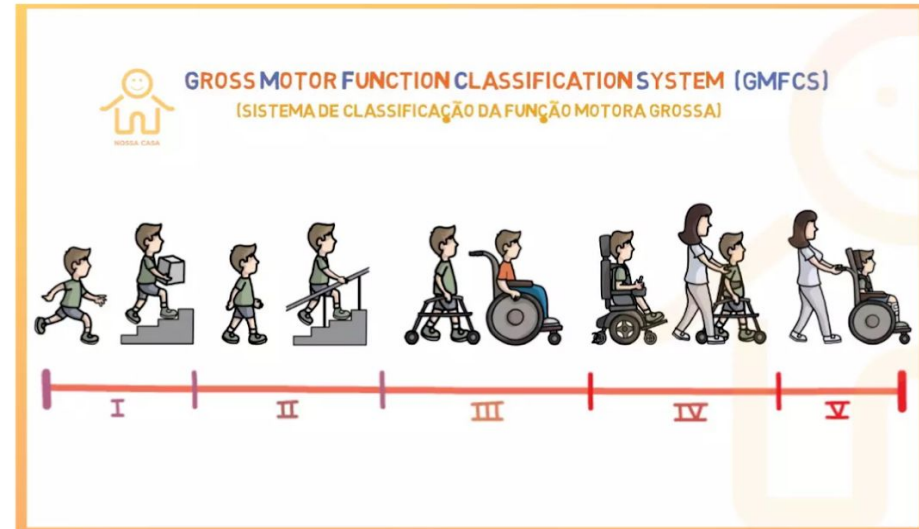
d.CFCS

e.GMFCS



Яку шкалу використовують в ерготерапії для стандартизованої оцінки рівня розвитку великих моторних функцій у дітей з церебральним паралічем?

- a. MACS
- b. FIM
- c. FMS
- d. CFCS
- e. GMFCS



Gross Motor Function Classification System (GMFCS),
<https://nossacasa.org.br/gmfcs/>

- a. MACS (Manual Ability Classification System): Використовується для оцінки здатності дитини маніпулювати предметами руками у повсякденному житті, тобто для дрібної моторики.
- b. FIM (Functional Independence Measure): Це загальна шкала для оцінки функціональної незалежності пацієнтів (переважно дорослих) у різних сферах (самообслуговування, контроль сечовипускання, пересування тощо). Вона не є спеціалізованою для великої моторики дітей з ЦП.
- c. FMS (Functional Mobility Scale): Оцінює функціональну мобільність на конкретних дистанціях (5, 50, 500 метрів), описуючи, який тип пересування використовує дитина. Вона доповнює GMFCS, але не оцінює загальний рівень розвитку великих моторних функцій.
- d. CFCS (Communication Function Classification System): Використовується для класифікації ефективності повсякденного спілкування дитини, тобто не стосується моторики.



Пацієнтці віком 16 років після перенесеної гострої правосторонньої пневмонії для запобігання розвитку спайок призначено лікувальний масаж. Укажіть правильну послідовність прийомів проведення лікувального масажу при захворюваннях органів дихання.

- a. Погладження, вібрація, розминання, розтирання
- b. Погладження, розминання, розтирання, вібрація
- c. Вібрація, розминання, погладження, розтирання
- d. Погладження, розтирання, розминання, вібрація
- e. Розтирання, погладження, розтирання, вібрація



Пацієнтці віком 16 років після перенесеної гострої правосторонньої пневмонії для запобігання розвитку спайок призначено лікувальний масаж. Укажіть правильну послідовність прийомів проведення лікувального масажу при захворюваннях органів дихання.

- a. Погладження, вібрація, розминання, розтирання
- b. Погладження, розминання, розтирання, вібрація
- c. Вібрація, розминання, погладження, розтирання
- d. Погладження, розтирання, розминання, вібрація**
- e. Розтирання, погладження, розтирання, вібрація



У дворічного хлопчика діагностовано периферичний параліч Дюшена-Ерба праворуч, зумовленого травматичним ураженням верхнього стовбура плечового сплетення. Під час об'єктивного обстеження пацієнта виявлено: значне зниження згинально-ліктьового та п'ястково-променевого рефлексів праворуч, розлади поверхневої чутливості на зовнішній поверхні плеча і передпліччя, болючість у надключичній ямці праворуч при натисканні. Які ще порушення спостерігатимуться у пацієнта?

- a.Приведення плеча та згинання в ліктьовому суглобі
- b.Відведення плеча та розгинання в ліктьовому суглобі
- c.-
- d.Приведення плеча та розгинання в ліктьовому суглобі
- e.Відведення плеча та згинання в ліктьовому суглобі



У дворічного хлопчика діагностовано периферичний параліч **Дюшена-Ерба** праворуч, зумовленого травматичним ураженням верхнього стовбура плечового сплетення. Під час об'єктивного обстеження пацієнта виявлено: значне зниження згинально-ліктьового та п'ястково-променевого рефлексів праворуч, розлади поверхневої чутливості на зовнішній поверхні плеча і передпліччя, болючість у надключичній ямці праворуч при натисканні. Які ще порушення спостерігатимуться у пацієнта?

- а.Приведення плеча та згинання в ліктьовому суглобі
- б.Відведення плеча та розгинання в ліктьовому суглобі
- с.-
- д.Приведення плеча та розгинання в ліктьовому суглобі
- е.Відведення плеча та згинання в ліктьовому суглобі



Які клінічні прояви клишоногості?

A. Супінація стопи та абдукція стопи

B. Еквінус у гомілково-надп'ятковому суглобі та аддукція стопи

C. Збільшення дорсіфлексії стопи

D. Абдукція стопи та пронація стопи

E. Пронація стопи та аддукція стопи



еквінус у гомілково-надп'ятковому суглобі (підшовне згинання стопи) та аддукцію стопи (приведення стопи до середини).

Які клінічні прояви клишоногості?

A. Супінація стопи та абдукція стопи

B. Еквінус у гомілково-надп'ятковому суглобі та аддукція стопи

C. Збільшення дорсіфлексії стопи

D. Абдукція стопи та пронація стопи

E. Пронація стопи та аддукція стопи



Вихідний показник пікфлоуметрії у пацієнта віком 15 років із бронхіальною астмою становив 600 л/хв. Який повторний показник на 5-ій хв відпочинку після тесту 6-хвилинної ходьби буде вказувати на реакцію бронхів (звуження) на фізичне навантаження?

A.550 л/хв

B.505 л/хв

C.615 л/хв

D.515 л/хв

E.690 л/хв



Вихідний показник пікфлоуметрії у пацієнта віком 15 років із бронхіальною астмою становив 600 \, \text{л/хв}. Який повторний показник на 5-ій хв відпочинку після тесту 6-хвилинної ходьби буде вказувати на реакцію бронхів (звуження) на фізичне навантаження?

A.550 л/хв

B.505 л/хв

C.615 л/хв

D.515 л/хв

E.690 л/хв

Пікфлоуметрія — методика діагностики функції зовнішнього дихання, яка визначає пікову об'ємну швидкість видиху. Пікфлоуметрія здійснюється за допомогою медичного приладу — пікфлоуметра.

Для оцінки реакції бронхів на фізичне навантаження у пацієнта з бронхіальною астмою після 6-хвилинного тесту ходьби, значуще зниження пікової швидкості видиху (показник пікфлоуметрії) зазвичай розглядають як падіння на 10-15% або більше від вихідного значення (зазвичай зниження пікової швидкості видиху на 10-15% і більше порівняно з вихідним значенням розглядається як значуще і свідчить про бронхоспазм.) .

Початкове значення пікфлоуметрії у пацієнта становить 600 л/хв. Таким чином, значуще зниження на 15% буде
відповідати:

$600 \times 0.15 = 90$ л/хв – різниця між початковим значенням та повторним показником.

$600 - 90 = 510$ л/хв – вихідний показник пікфлоуметрії, що є критичним до бронхоспазму.

Серед усіх варіантів відповіді, найнижчим показником є відповідь у 505 л/хв, що й є правильною відповіддю.

До ерготерапевта звернулась сім'я з трирічним хлопчиком, який хворіє на ДЦП (геміпарез 3 рівень за GMFCS). Скаржаться на відсутність у дитини навичку пиття з чашки (відсутність втягування рідини). Яка стратегія формування пиття буде найактуальнішою?

- A.Порекомендувати дитині відвідування логопеда та отримання логопедичного масажу
- B.Заміна рідини за смаком уподобання дитини та формування змикання губ на чашці
- C.Заміна чашки на пляшку через соломинку
- D.Терапевтичні вправи направлені на розвиток м'язів лиця
- E.За допомогою спеціального стаканчику та тренування втягування за рахунок використання тягучої рідини



До ерготерапевта звернулась сім'я з трирічним хлопчиком, який хворіє на ДЦП (геміпарез 3 рівень за GMFCS). Скаржаться на відсутність у дитини навичку пиття з чашки (відсутність втягування рідини). Яка стратегія формування пиття буде найактуальнішою?

А.Порекомендувати дитині відвідування логопеда та отримання логопедичного масажу

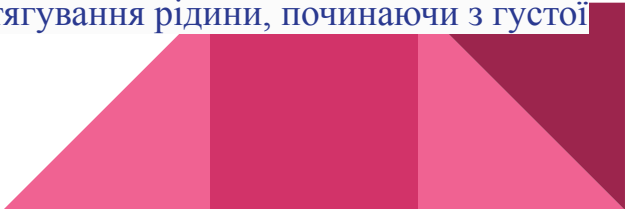
В.Заміна рідини за смаком уподобання дитини та формування змикання губ на чашці

С.Заміна чашки на пляшку через соломинку

Д.Терапевтичні вправи направлені на розвиток м'язів лиця

Е.За допомогою спеціального стаканчика та тренування втягування за рахунок використання тягучої рідини

Для формування навичку пиття з чашки у дитини з ДЦП (геміпарез 3 рівень за GMFCS) актуальним буде використання спеціального стаканчика з виїмкою для носа та тренування втягування рідини, починаючи з густої консистенції (наприклад, пюре або йогурт), щоб полегшити процес.



Під час оцінки постави пацієнта віком 18 років було виявлено викривлення хребта у фронтальній площині.
Який тест доцільно провести у цьому разі для деталізації діагнозу?

A. Патрика

B. Філіпса

C. Ласега

D. Ловетта

E. Адамса



Під час оцінки постави пацієнта віком 18 років було виявлено викривлення хребта у фронтальній площині. Який тест доцільно провести у цьому разі для деталізації діагнозу?

- A. Патрика
- B. Філіпса
- C. Ласега
- D. Ловетта
- E. Адамса**

Тест Адамса використовується для діагностики сколіозу. Пацієнт нахиляється вперед, а лікар оцінює наявність реберного горба, що свідчить про структурний сколіоз.



- А. Патрика (Тест Фабера): Використовується для оцінки кульшового суглоба та крижово-клубового зчленування (підозра на коксартроз, сакроілеїт).
- В. Філіпса: Не є стандартним ортопедичним тестом для оцінки постави. Назва може бути помилковою.
- С. Ласега (Підйом випрямленої ноги): Використовується для діагностики ущемлення сідничного нерва та патології поперекового відділу хребта, що проявляється больовим синдромом.
- D. Ловетта: Це метод мануального м'язового тестування для оцінки сили окремих м'язових груп.



На якому терміні вагітності проводиться стимуляція пологів у вагітної жінки з діагнозом ожиріння III ступеня?

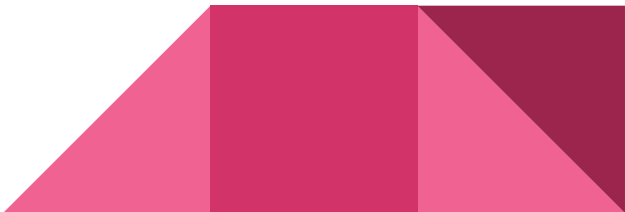
A.35--36 тижнів

B.38--39 тижнів

C.39--40 тижнів

D.40--41 тижнів

E.---



На якому терміні вагітності проводиться стимуляція пологів у вагітної жінки з діагнозом ожиріння III ступеня?

A.35--36 тижнів

B.38--39 тижнів

C.39--40 тижнів

D.40--41 тижнів

E.---



- А. 35–36 тижнів: Це занадто рано. Плід вважається доношеним лише з 37 тижня. Пологи на 35-36 тижні - це передчасні пологи, що несе ризики для дитини, пов'язані з недоношеністю.
- С. 39–40 тижнів: Хоча це термін для доношеної вагітності, для жінок з ожирінням III ступеня очікування до цього терміну підвищує ризик внутрішньоутробної загибелі плода.
- D. 40–41 тижнів: Це термін переношеної вагітності, ризики для плода значно зростають.

Через підвищений ризик раптової внутрішньоутробної загибелі плода в терміні після 39 тижнів вагітності, сучасні клінічні протоколи (включаючи рекомендації Американського коледжу акушерів-гінекологів - ACOG) рекомендують запобіжну стимуляцію пологів на 38-39 тижні вагітності для жінок з ожирінням.



Дитина народилася з масою тіла 3500 г, довжиною - 51 см. Через 6 місяців має масу - 8700 г , довжину - 67,5 см . Оцініть фізичний розвиток дитини.

А. Гіпотрофія 2-го ступеня

В. Гіпотрофія 1-го ступеня

С. Нормальний

Д. Паратрофія

Е. Гіпостатура



Дитина народилася з масою тіла 3500 г, довжиною - 51 см. Через 6 місяців має масу - 8700 г , довжину - 67,5 см . Оцініть фізичний розвиток дитини.

- А. Гіпотрофія 2-го ступеня
 - В. Гіпотрофія 1-го ступеня
 - С. Нормальний
 - Д. Паратрофія
 - Е. Гіпостатура
- Гіпотрофія – дефіцит маси по відношенню до довжини.
 - Паратрофія – надлишкова маса тіла.
 - Гіпостатура – рівномірне відставання маси і довжини.

Паратрофія- це надлишкова маса тіла зі схильністю до ожиріння. Для діагностики паратрофії потрібно, щоб вага перевищувала норму більш ніж на 10%. У нашому випадку вага хоча і висока, але знаходиться в межах норми для здорової дитини, особливо якщо врахувати, що і довжина тіла також вище середньої. Діагноз "паратрофія" зазвичай ставлять, коли вага значно (на 2 і більше центильних коридори) випереджає зріст.

Однорічний хлопчик має порушення психомоторного розвитку : у положенні на животі може піднімати та утримувати голову під кутом більше 45 градусів , у положенні на спині утримує голову на одній лінії з тулубом , підносить руки до середньої лінії , дістає руками до колін. Самостійно не перевертається, не сідає і не сидить. Який вид вертикалізатора буде найбільш оптимальним у цьому разі?

- A. Мобільний
- B. Що забезпечує передню підтримку
- C. Що забезпечує підтримку ззаду
- D. Із переходом з положення сидячи у положення стоячи
- E. Багатопозиційний



Однорічний хлопчик має порушення психомоторного розвитку : у положенні на животі може піднімати та утримувати голову під кутом більше 45 градусів , у положенні на спині утримує голову на одній лінії з тулубом , підносить руки до середньої лінії , дістає руками до колін. Самостійно не перевертається, не сідає і не сидить. Який вид вертикалізатора буде найбільш оптимальним у цьому разі?

- A. Мобільний
- B. Що забезпечує передню підтримку
- C. Що забезпечує підтримку ззаду
- D. Із переходом з положення сидячи у положення стоячи
- E. Багатопозиційний



Багатопозиційні моделі дозволяють адаптувати положення дитини відповідно до рівня її моторного контролю.

Вони ідеальні у випадках:

- варіативності контролю голови
- необхідності змінювати кут нахилу
- потреби поступової вертикалізації

Цей тип дає змогу знімати або додавати елементи підтримки (підголівник, підніжки, столик), що особливо важливо для дітей, які ще не сидять, але вже проявляють активність у положенні лежачи.

Чому не інші варіанти?

- Передня підтримка — підходить дітям із хорошим контролем голови. Тут це ще рано.
- Підтримка ззаду — краще для дітей із зовсім слабким контролем голови. Наш малюк вже може трохи тримати.
- Сидячи-стоячи — потребує самостійного сидіння, чого поки нема.
- Мобільний — складний для дітей із низьким контролем моторики та сили.



Вкажіть хапання , що відноситься до первинного

- A.Хапання кінчиками трьох пальців
- B.Замінний тип хапання, що виконується іншими частинами тіла
- C.Хапання за допомогою ортеза
- D.Хапання, що виконується пальцями або долонею
- E.Хапання за допомогою допоміжного засобу



Вкажіть хапання , що відноситься до первинного

A.Хапання кінчиками трьох пальців

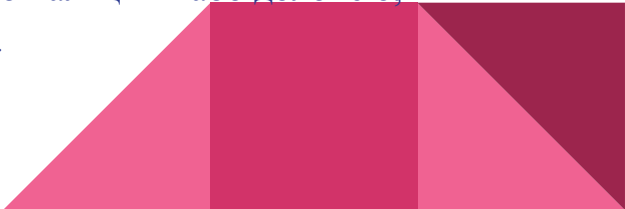
B.Замінний тип хапання, що виконується іншими частинами тіла

C.Хапання за допомогою ортеза

D.Хапання, що виконується пальцями або долонею

E.Хапання за допомогою допоміжного засобу

Первинні типи хапання включають ті, що здійснюються безпосередньо пальцями або долонею, наприклад, пальцеве хапання, долонне хапання, циліндричне хапання.



Класифікація(типи)хапання:

- ▶ первинне - хапання, що виконується пальцями або долонею
- ▶ Вторинне - замінний тип хапання, що виконується іншими частинами тіла, наприклад, голова - плече, зуби, пахви, лікоть тощо.
- ▶ третинне - хапання за допомогою ортеза чи допоміжного засобу



Передчасно народжена дитина щоденно отримує до 10-12 стресових процедур догляду , зокрема забір крові.
Яку шкалу застосовують для вимірювання процедурного болю недоношених і доношених немовлят ?

- A. NBAS
- B. Шкалу ВАШ
- C. NIPS
- D. N-PASS
- E. -



Передчасно народжена дитина щоденно отримує до 10-12 стресових процедур догляду , зокрема забір крові.
Яку шкалу застосовують для вимірювання процедурного болю недоношених і доношених немовлят ?

- A. NBAS
- B. Шкалу ВАШ
- C. **NIPS**
- D. N-PASS
- E. -



Шкала оцінки болю у новонароджених та дітей до 1 року (NIPS) - це поведінкова шкала, яка може використовуватися як для доношених, так і недоношених дітей. Вона була адаптована зі шкали CHEOPS і використовує поведінкові реакції як показник дитячого болю або дистресу. Складається з шести показників.

- вираз обличчя
- плач
- характер дихання
- руки
- ноги
- стан неспання

Загальний показник болю коливається від 0-7. Запропоновані втручання, з огляду і на інтенсивність болю у немовляти, перераховані нижче. Показники допомагають у диференціюванні болю і збудження, а нефармакологічне втручання може допомогти розмежувати ці два стани (наприклад, зміна мокрого підгузника, годування немовляти, зміна положення тощо).

0-2 = легкий біль: втручання не потрібне

3-4 = легкий - помірний біль: нефармакологічне втручання з переоцінкою через 30 хвилин

> 4 = сильний біль: нефармакологічне втручання та, можливо, фармакологічне втручання з повторною оцінкою протягом 30 хвилин

- NBAS (Шкала оцінки поведінки новонародженого Бразелтона): Це комплексна шкала для оцінки неврологічного та поведінкового розвитку немовляти, а не спеціалізований інструмент для вимірювання гострого процедурного болю.
- Шкала ВАШ (Візуально-аналогова шкала): Використовується для дорослих та дітей старшого віку, які можуть самостійно оцінити свій біль. Для немовлят, які не можуть вербалізувати біль, вона не застосовується.
- N-PASS (Neonatal Pain, Agitation and Sedation Scale): Ця шкала також використовується в неонатології, але вона більш універсальна і призначена для оцінки не лише болю, але й збудження та седації, часто протягом тривалого часу (наприклад, у відділенні інтенсивної терапії). Для цілеспрямованої оцінки гострого процедурного болю NIPS є більш поширеним і спеціалізованим вибором.



Новонародженій дитині виконується погладжування щоки праворуч. Оберіть рефлекторну відповідь, яка буде вказувати на зрілий пошуковий рефлекс.

- A. Поворот голови ліворуч та закривання рота
- B. Поворот голови ліворуч та відкривання
- C. Поворот голови праворуч та відкривання рота
- D. -
- E. Поворот голови праворуч та закривання



Новонародженій дитині виконується погладжування щоки праворуч. Оберіть рефлекторну відповідь, яка буде вказувати на зрілий пошуковий рефлекс.

- A. Поворот голови ліворуч та закривання рота
- B. Поворот голови ліворуч та відкривання
- C. Поворот голови праворуч та відкривання рота**
- D. -
- E. Поворот голови праворуч та закривання



Передчасно народжене немовля (скоригований вік 36 тижнів) має підвищений рівень розвитку апное.
Укажіть позиціонуюче положення для здійснення орального годування через соску.

- A.-
- B. Горизонтальне положення на спині
- C. Альтернативне положення «живіт до живота»
- D. Альтернативне положення на спині
- E. Вертикальне положення (сидячи)



Передчасно народжене немовля (скоригований вік 36 тижнів) має підвищений рівень розвитку апное.
Укажіть позиціонуюче положення для здійснення орального годування через соску.

A.-

B. Горизонтальне положення на спині

C. Альтернативне положення «живіт до живота»

D. Альтернативне положення на спині

E. Вертикальне положення (сидячи)



У передчасно народжених дітей з підвищеним ризиком апное годування через соску вимагає спеціальних позицій, які:

1. Сприяють зручності та стабільності дитини.
2. Зменшують енерговитрати.
3. Підтримують ефективне ковтання та дихання, знижуючи ризик аспірації.

Положення **«живіт до живота»** (коли дитина розташована під кутом, обличчям до годувальника, її живіт притискається до живота дорослого) є оптимальним, оскільки:

- Забезпечує фізіологічну згорнуту позицію (злегка зігнуту), схожу на позу ембріона, що дає дитині відчуття безпеки.
- Сприяє кращій координації смоктання-ковтання-дихання.
- Дозволяє годувальнику краще контролювати положення голови та шиї дитини.

Чому інші варіанти менш підходящі:

- А. Горизонтальне положення на спині: Не є рекомендованим для годування, оскільки підвищує ризик аспірації та ускладнює дихання.
- В. Альтернативне положення на спині: Хоча може використовуватись, положення «живіт до живота» зазвичай вважається більш сприятливим для стабілізації дитини та покращення координації годування.
- D. Вертикальне положення (сидячи): Для дитини з скоригованим віком 36 тижнів це положення ще занадто складне для підтримки та ефективного годування, воно вимагає добре розвиненого контролю голови та тулуба, якого у передчасно народженої дитини ще немає.

У передчасно народженої дитини оцінюється здатність до орального годування. Укажіть фазу ковтання , під час якої будуть активно задіяні нижня щелепа, язик, м'яке та тверде піднебіння з частковим залученням губ.

A. Фарингеальна

B. Початкова езофагеальна

C. -

D. Ротова

E. Езофагеальна



У передчасно народженої дитини оцінюється здатність до орального годування. Укажіть фазу ковтання, під час якої будуть активно задіяні нижня щелепа, язик, м'яке та тверде піднебіння з частковим залученням губ.

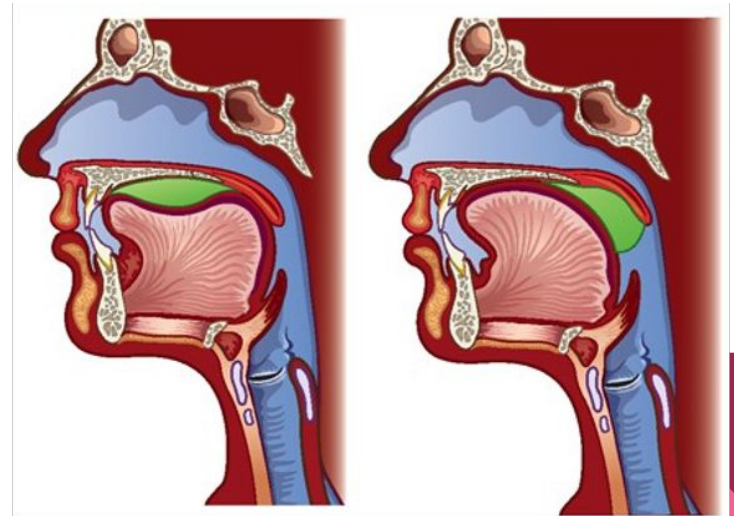
А. Фарингеальна

В. Початкова езофагеальна

С. -

Д. Ротова

Е. Езофагеальна



Питання описує фазу, в якій задіяні нижня щелепа, язик, м'яке та тверде піднебіння з частковим залученням губ. Це дійсно звучить як ротова фаза. Однак ключовим моментом є те, що в стандартній класифікації ротова фаза є добровільною і підсвідомою, а зазначені дії більш характерні для незрілого моделю руху, який часто спостерігається у передчасно народжених дітей.

1. Ротова фаза: Це підготовча фаза, де відбувається смоктання, формування болюсу та його переміщення язиком до задньої частини ротової порожнини. Активно задіяні губи, щелепи, язик і піднебіння.
2. Фарингеальна фаза: Це рефлекторна фаза, яка ініціюється, коли болюс торкається кореня язика. Вона забезпечує закриття гортані, підйом глотки та відкриття верхнього стравохідного сфінктера (ВСС).
3. Початкова езофагеальна фаза (або фаринго-езофагеальна): Це критично важливий перехідний момент. Він починається з мимовільного відкриття верхнього стравохідного сфінктера (ВСС), що дозволяє болюсу увійти в стравохід. У цей самий момент для остаточного проштовхування болюсу з глотки та запобігання його поверненню назад можуть продовжувати залучатися м'язи, активні в кінці ротової та на початку глоткової фази, зокрема:
 - Язик робить остаточний поштовх назад.
 - Щелепа стабілізується.
 - М'яке піднебіння повністю закриває носоглотку.
 - Губи можуть ритмічно рухатися.

Висновок: Опис у питанні найбільш точно відповідає саме початковій езофагеальній фазі, оскільки це фаза, де мимовільне відкриття сфінктера поєднується з останніми активними рухами ротових структур для успішного переходу болюсу з глотки в стравохід. Це особливо важливо для оцінки координації у передчасно народжених дітей, у яких цей перехід часто є найбільш уразливим місцем.

Який метод дозволяє обстежити показники фізичного розвитку, визначити статуру, склад тіла, силу окремих м'язових груп, ступінь рухливості в суглобах і зміни цих параметрів в процесі занять?

- a. Ультразвуковий
- b. Соматометричний
- c. Рентгенологічний
- d. Соматографічний
- e. Соматоскопічний



Який метод дозволяє обстежити показники фізичного розвитку, визначити статуру, склад тіла, силу окремих м'язових груп, ступінь рухливості в суглобах і зміни цих параметрів в процесі занять?

a. Ультразвуковий

b. Соматометричний (правильний у кроці)

c. Рентгенологічний

d. Соматографічний

e. Соматоскопічний



Текст питання

Який метод дозволяє обстежити показники фізичного розвитку, застосування статуру, склад тіла, силу окремих м'язових груп, ступінь рухливості в вузлах і змінах цих параметрів у процесі заняття?

Питання 17 Відповідь



а.

Соматометричний



б.

Соматоскопічний



с.

Ультразвуковий



г.

Соматографічний



е.

Рентгенологічний

Коментар

Правильна відповідь: Соматометричний

У дитини віком 14 років з ДЦП виражений патерн спастичності у вигляді приведення стегна. Лікарем ФРМ введено ботулотоксин у великий привідний м'яз.

Які результати очікуються в цьому разі?

- a. Полегшення гігієни періанальної зони
- b. Покращення ходьби
- c. Покращення опори на п'ятку
- d. Покращення функції сидіння
- e. Полегшення під час носіння взуття



У дитини віком 14 років з ДЦП виражений патерн спастичності у вигляді приведення стегна. Лікарем ФРМ введено ботулотоксин у великий привідний м'яз.

Які результати очікуються в цьому разі?

а. Полегшення гігієни періанальної зони

б. Покращення ходьби

с. Покращення опори на п'ятку

д. Покращення функції сидіння

е. Полегшення під час носіння взуття



М'яз, у який було введено ботулотоксин — великий привідний м'яз (аддуктор). Його основна функція — приведення стегна, тобто зведення ніг разом.

При вираженій спастичності цього м'яза у дітей з ЦП виникають наступні проблеми:

1. Приведення та перехрещування ніг (так звана "схрещена поза" або "scissoring gait").
2. Труднощі з розведенням стегон, що робить гігієнічні процедури, одягання штанів, заміну підгузка та, що найважливіше, гігієну періанальної (проміжної) зони вкрай складними або навіть болючими.

Введення ботулотоксину в великий привідний м'яз має на меті:

- Зменшити спастичність саме цього м'яза.
- Збільшити обсяг рухів у кульшових суглобах, а саме — можливість відведення стегон (розведення ніг у сторони).

Безпосереднім результатом цього буде саме полегшення догляду та проведення гігієни в міжножній ділянці, оскільки опікун зможе легше розвести дитині ноги.



Чому інші варіанти, хоча й бажані, не є прямими результатами ін'єкції саме в цей м'яз:

- б. Покращення ходьби: Це може бути непрямым наслідком, якщо приведення стегон було головною перешкодою для ходи. Однак для покращення ходи зазвичай потрібна комплексна робота над багатьма м'язовими групами.
- с. Покращення опори на п'ятку: Проблема опори на п'ятку зазвичай пов'язана зі спастичністю інших м'язів, зокрема триголового м'яза гомілки (що призводить до ходи на носках). Ін'єкція в привідний м'яз стегна не впливає безпосередньо на цю проблему.
- d. Покращення функції сидіння: Може статися, якщо сильна спастичність привідних м'язів заважала стабільному сидінню. Однак найбільш очевидним і безпосереднім результатом є саме полегшення догляду.
- е. Полегшення під час носіння взуття: Ця проблема більше пов'язана зі спастичністю м'язів гомілки та стопи, а не з привідними м'язами стегна.

У пацієнта діагностовано ДЦП. Що з нижченаведеного може обмежувати використання терапевтичних вправ у воді?

a.-

b. Контрактури

c. Спастичний парепарез

d. Затримка психічного розвитку

e. Епілептичний напад



У пацієнта діагностовано ДЦП. Що з нижченаведеного може обмежувати використання терапевтичних вправ у воді?

- a.-
- b. Контрактури
- c. Спастичний парепарез
- d. Затримка психічного розвитку
- e. Епілептичний напад**



Що є надійним прогностичним фактором щодо здатності дитини з церебральним паралічем самотійно пересуватися?

- a. Здатність самотійно сидіти до 2-х років
- b. Наявність спастичності
- c. Повзання до 3-х років
- d. Передчасні пологи (до 32-х тижнів)
- e. Збережені примітивні рефлекси



Що є надійним прогностичним фактором щодо здатності дитини з церебральним паралічем самотійно пересуватися?

а. Здатність самотійно сидіти до 2-х років

б. Наявність спастичності

с. Повзання до 3-х років

д. Передчасні пологи (до 32-х тижнів)

е. Збережені примітивні рефлекси



У дитячій неврології та реабілітації здатність до самостійного (сталого) сидіння без підтримки є одним з найважливіших прогностичних факторів для майбутньої функції пересування у дітей з церебральним паралічем (ЦП).

Чому це так:

- Контроль тулуба: Самостійне сидіння вимагає хорошої контрольної сили м'язів тулуба та таза. Цей контроль є критично важливим фундаментом для всіх складніших функцій, таких як стояти, підтримувати рівновагу і ходити.

Чому інші варіанти не є надійними прогностичними факторами:

- b. Наявність спастичності: Тип та ступінь спастичності впливають на функцію, але сама по собі наявність спастичності не є вирішальним прогностичним фактором. Деякі діти зі спастичними формами ЦП ходять, а діти з атаксією або гіпотонією — ні.
- c. Повзання до 3-х років: Це дуже пізній термін. Якщо дитина починає повзати лише до 3 років, це вказує на значну затримку рухового розвитку, і прогноз для самостійного пересування (ходьби) є сумнівним. Здатність сидіти до 2 років є значно більш раннім і точним предиктором.
- d. Передчасні пологи (до 32-х тижнів): Це фактор ризику розвитку ЦП, але не прогностичний фактор для здатності до ходьби серед дітей, у яких ЦП вже діагностовано. Багато дітей, народжених передчасно, мають легкі форми ЦП і ходять самостійно.
- e. Збережені примітивні рефлексі: Тривале збереження стійких примітивних рефлексів (наприклад, асиметричного шийно-тонічного) є ознакою порушення розвитку нервової системи і часто погіршує прогноз, але це менш конкретний і стандартизований маркер, порівняно з віком набуття ключових моторних навичок (таких як сидіння).

Пацієнтка віком 22 роки, термін вагітності 12 тижнів, страждає на ожиріння II ступеня. Який лабораторний аналіз має бути обов'язково призначений для цієї вагітної?

А) Аналіз крові на ревмапроби

Б) Глюкозотолерантний тест

В) Аналіз крові на ВІЛ

Г) Загальний аналіз сечі

Д) Загальний аналіз крові



Пацієнтка віком 22 роки, термін вагітності 12 тижнів, страждає на ожиріння II ступеня. Який лабораторний аналіз має бути обов'язково призначений для цієї вагітної?

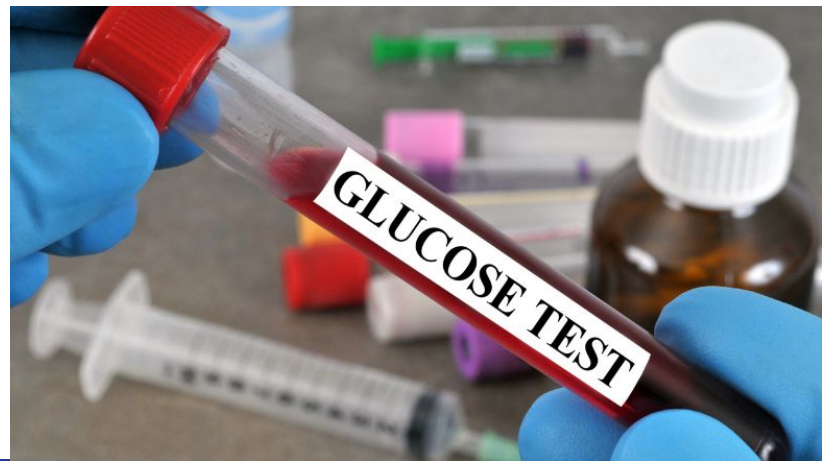
А) Аналіз крові на ревмапроби

Б) Глюкозотолерантний тест

В) Аналіз крові на ВІЛ

Г) Загальний аналіз сечі

Д) Загальний аналіз крові



Вагітна пацієнтка 22 років, на терміні 12 тижнів з ожирінням II ступеня. Ожиріння значно підвищує ризик розвитку гестаційного діабету (цукрового діабету, що виникає під час вагітності).

Що таке глюкотолерантний тест?

- Це аналіз, який показує, як організм впорається з навантаженням глюкозою.
- Пацієнтка натще випиває певну кількість розчину глюкози, після чого роблять послідовні заміри рівня цукру в крові через 1 і 2 години.
- Якщо рівень цукру залишається завищеним – це свідчить про порушення толерантності, гестаційний діабет.

Чому інші варіанти не є пріоритетними у цій ситуації?

- **Аналіз крові на ревмапроби (А)** – використовується для діагностики ревматичних захворювань, які тут не є пріоритетом.
 - **Аналіз крові на ВІЛ (С)** – звичайно виконується під час вагітності, але не є спеціально зумовленим фактором саме для пацієнток з ожирінням у 12 тижнів.
 - **Загальний аналіз сечі (D)** – важливий для загального контролю, особливо у вагітних, але при ожирінні першочергово потрібно виключити гестаційний діабет.
 - **Загальний аналіз крові (Е)** – загальне обстеження, що важливо, але не вирішує проблему ризику метаболічних порушень як глюкотолерантний тест.
- 

Ура!

